AV RUI BARBOSA, 479, - até 1061 - lado ímpar, HELIÓPOLIS, GARANHUNS - PE - CEP: 55295-530 - F:(87) 37649074

Processo nº 0000200-22.2025.8.17.2640

AUTOR(A): MARIA ZELIA BISPO DA SILVA

RÉU: CENTRO HOSPITALAR DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO, FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, PGE - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais ajuizada por **MARIA ZÉLIA BISPO DA SILVA**, em face do **CENTRO HOSPITALAR DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.339.827/0001-40, e **SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SISMEPE,** alegando os fatos a seguir:

"A Autora é beneficiária do plano de saúde Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco (SISMEPE) desde 30/03/2001, como dependente de seu esposo, Cícero Roberto da Silva, tendo como número do beneficiário (antigo SAME) 29978/1, conforme carteira em anexo (Doc. 6): A paciente é portadora de Neoplasia Maligna de Encéfalo (CID 10 C71), também denominada Glioma de Alto Grau, um tipo de câncer cerebral descoberto no início do ano de 2024. Em 12 de agosto de 2024 a paciente foi submetida a cirurgia para retirada do tumor e coleta de material para biópsia. Após o resultado, em 22 de agosto de 2024, foi constatada a necessidade de continuidade do tratamento através de quimioterapia e radioterapia. Em razão disso, em 17 de setembro de 2024, a Autora iniciou as sessões de radioterapia e o tratamento quimioterápico com o medicamento antineoplásico oral Temodal® (Temozolamida) 75mg/m2 (dose total diária de 115mg) e, depois, 200mg/m2 (dose total diária de 300mg), conforme indicação médica: Ambos os tratamentos foram realizados por 28 (vinte e oito) dias seguidos. Destaca-se que o plano de saúde da Autora cobriu todos os eventos médicos até aqui descritos, inclusive o fornecimento do medicamento quimioterápico Temozolamida que a paciente, ora Autora, recebia e fazia uso na própria clínica.

Em 28 de outubro houve a conclusão do tratamento radioterápico e da primeira etapa da quimioterapia. Neste intervalo, sem uso da medicação, a paciente apresentou um episódio convulsivo durante o sono, o que pode, também, resultar em piora do quadro clínico. Um mês depois, iniciou-se a segunda etapa do tratamento quimioterápico, com indicação de administração da Temozolamida na dosagem de 300 mg durante cinco dias consecutivos, respeitando o intervalo de 28 (vinte e oito) dias entre as doses, que agora são aplicadas em casa, conforme apresentada no receituário médico anexo. Essa segunda etapa do tratamento terá duração de um ano. A primeira dose do antineoplásico foi retirada no Centro Oncológico de Garanhuns em 27 de novembro de 2024, pelo filho da Autora, Roberto, considerando o grave estado de saúde da paciente, que está extremamente debilitada, incapaz de deambular, falar e com imobilidade na parte superior do lado direito do corpo. A retirada do medicamento foi realizada nesse local, indicado pelo plano de saúde réu, SISMEPE, responsável pela prestação de assistência à saúde aos policiais militares do Estado de Pernambuco. Quando o filho da Autora compareceu ao Centro Oncológico para retirar a segunda dose da medicação, programada

para administração em 26 de dezembro de 2024, recebeu uma negativa na liberação do medicamento. O Centro alegou que não havia autorização do plano de saúde réu devido à falta de uma assinatura, alegadamente indispensável, de um Superior Oficial da Polícia Militar. Diante dessa negativa, a família da Autora questionou alternativas para viabilizar a assinatura, como a possibilidade de contato direto com o Oficial, o uso de assinatura digital ou mesmo a dispensa desse requisito, considerando a urgência do caso e o estado crítico da paciente, mas nenhuma dessas opções foi atendida

Dessa forma, a única "opção" que restou à Autora foi aguardar o fornecimento da medicação, que já se encontra com um ATRASO DE DEZESSETE DIAS. Essa demora, em razão da evidente gravidade e agressividade da doença, implica em inúmeros prejuízos à paciente, como a regressão dos avanços obtidos no tratamento, a piora acelerada do quadro clínico, o aumento do sofrimento físico e emocional, e o risco iminente de comprometimento irreversível da saúde, ou até mesmo de perda da vida, caso o fornecimento não seja regularizado com a urgência que o caso demanda. Desde então, os familiares da Autora vêm realizando, diariamente, diversas tentativas – que têm se mostrado inúteis – de obter a medicação indispensável para o tratamento da Requerente, mas o 4º Batalhão da Polícia Militar – Barreto de Menezes, representante do Réu, não apresenta motivos plausíveis e segue negando a entrega da medicação..

Em ligação telefônica realizada em 08 de janeiro de 2025 (gravações anexas, Docs. 8 ao 10) foi informado que o contrato entre o SISMEPE e o Centro de Oncologia de Garanhuns não foi renovado, outro subterfúgio para que o Réu siga se eximindo de suas obrigações. Veja o que foi dito pela representante do Réu (Gravação 2 em anexo, Doc. 9): O contrato ainda não foi renovado, viu? Está aguardando o posicionamento do pessoal do {inteligível} da da [sic] direção, para liberar os procedimentos realmente de vocês, mas não tem resposta [sic]. (Transcrição de trecho da Gravação 2) É evidente que o Réu não apresenta informações concretas sobre os contratos vigentes ou as medidas que estão sendo tomadas para regularizar a situação. A resposta vaga e genérica da representante do Réu demonstra a total ausência de comprometimento em garantir a continuidade dos tratamentos necessários, o que acaba por prejudicar gravemente a Autora.

Além disso, a justificativa apresentada não esclarece a quais "contratos" se refere, deixando em aberto um ponto crucial para a resolução do caso. Essa postura omissa e evasiva evidencia o descaso do Réu em relação à Autora, agravando ainda mais os danos causados à sua saúde e inviabilizando a proteção ao direito fundamental à vida, que deveria ser assegurado pelo plano de saúde. Portanto, fica claro que o Réu, ao invés de solucionar os entraves e viabilizar o tratamento da Autora, segue utilizando argumentos confusos e sem fundamento para justificar a ausência de atendimento, em flagrante violação às obrigações contratuais e ao dever de transparência. Após a demora e a falta de posicionamento do Réu, o filho da Autora passou a solicitar uma negativa documental para entender sob qual alegação ou justificativa o plano de saúde se eximia de entregar medicação urgente de tratamento oncológico em curso. Entretanto, essa negativa também não foi disponibilizada até a presente data. Esse comportamento, somado à suposta não renovação do contrato sem qualquer esclarecimento, à ausência de oferecimento de alternativas para o fornecimento do tratamento e à omissão em formalizar uma justificativa para a negativa, evidencia o descaso do plano de saúde com os seus beneficiários, colocando em risco a saúde e a vida daqueles que dele dependem. Já transcorreram MAIS DE DUAS SEMANAS da data correta de administração da medicação, representando risco de piora iminente ao caso clínico da Autora, tendo em vista que Glioma de Alto Grau é um tumor de crescimento acelerado e agressivo ao Sistema Nervoso Central e Periférico. Por estes motivos, vem a Autora requerer ao Judiciário a atenção ao seu caso e obrigar ao plano de saúde Réu a prestar o devido cumprimento da prescrição médica que indica o tratamento, fornecendo a medicação antineoplásica Temodal® (Temozolamida) na dosagem de 300 mg com a urgência que o caso demanda."

Requereu a concessão da tutela de urgência para compelir o Centro Hospitalar da Polícia Militar de Pernambuco e SISMEPE, que forneça a Autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Temodal® (Temozolamida) 300 mg, sendo ministradas cinco doses seguidas a cada 28 (vinte e oito) dias, no total de doze ciclos (um ano).

Contestação da parte ré, aventando preliminarmente, carência da ação, pretensão não resistida, violação ao princípio da isonomia – preferência injustificável, desestabilização do sistema de saúde dos militares de Pernambuco, da origem do SISMEPE e sua forma de custeio, não incidência das normas consumeristas. Requereu o indeferimento do pedido de tutela de urgência e a improcedência dos pedidos.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

Decisão determinando o sequestro e liberação de alvará em benefício do réu, face a liberação da autorização posterior a decisão judicial.
A parte autora juntou réplica reiterando os termos da inicial.

É o relatório. **DECIDO**.

A parte autora aventou que não conseguiu autorização/fornecimento de fármacos para realização e tratamento requerido.

O SISMEPE é um sistema de adesão compulsória para os militares, ativos e inativos, conforme se pode concluir dos artigos 2º, § 4º, e 18, da Lei Estadual nº 13.264/2007, cujo custeio conta com a participação dos seus beneficiários, além de contribuição fixa do Tesouro Estadual, razão pela qual sua função não se confunde com a desempenhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cujo acesso é universal e igualitário, sem qualquer limite de cobertura de tratamentos. 4. Embora a Lei Federal nº 9.656 /98 não abranja os sistemas de saúde mantidos pelas pessoas jurídicas de direito público para os militares, estes militares, mesmo não qualificados como consumidores (na acepção tradicional de direito privado, não podem ficar à completa mercê das decisões administrativas que deliberem incluir ou excluir determinados procedimentos do âmbito de cobertura, o que em última análise resultaria em cláusula potestativa francamente incompatível com o caráter oneroso do sistema.

Pois bem, a resistência do SISMEPE em fornecer o procedimento a parte autora se mostra desarrazoada face o cumprimento de suas obrigações perante aquele e o direito constitucional a saúde.

O réu alegou a inexistência de direito postulado e não incidência das normas consumeristas, tais alegações não devem prosperar, haja vista a indisponibilidade do tratamento a parte autora pelo SISMEPE é inapropriada mesmo diante de um plano de saúde considerado de autogestão nos termos da Súmula 608 do STJ.

Neste sentido é a jurisprudência:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Francisco Bandeira de Mello AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000379-29.2018.8 .17.9000 COMARCA: Recife AGRAVANTE: Estado de Pernambuco AGRAVADA: Francisca Joseiza da Silva Modesto Rodrigues RELATOR: Des. Francisco Bandeira de Mello EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. CUSTEIO, PELO SISMEPE - SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT, POR INTERMÉDIO DE PROFISSIONAIS E/OU HOSPITAIS A ELE NÃO CREDENCIADOS/CONVENIADOS. BENEFICIÁRIA/PACIENTE PORTADORA DE CARCINOSSARCOMA DE ENDOMÉTRIO (CID- C.54) . COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. DEVER DO SISMEPE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . O SISMEPE - Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco foi criado pela Lei Estadual nº 13.264, de 29 de junho de 2007, a qual se encontra regulamentada pelo Decreto nº 34.680, de 12 de março de 2010. 2 . Destina-se à prestação de serviços de assistência à saúde, no âmbito do Estado de Pernambuco, exclusivamente aos seus beneficiários definidos no Capítulo III daquela Lei, através de ações de medicina preventiva e curativa, desenvolvidas mediante aplicação de programas específicos de assistência à saúde e por intermédio das organizações militares de saúde da Polícia Militar de Pernambuco - PMPE e excepcionalmente por entidades, profissionais ou hospitais credenciados ao SISMEPE, na forma desta Lei. 3. Da leitura dos artigos 2º, § 4º, e 18, da Lei Estadual nº 13.264/2007, infere-se que o SISMEPE é um sistema de adesão compulsória para os militares, ativos e inativos, cujo custeio conta com a participação dos seus beneficiários, além de contribuição fixa do Tesouro Estadual, razão pela qual sua função não se confunde com a desempenhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cujo acesso é universal e igualitário, sem qualquer limite de cobertura de tratamentos . 4. Depreende-se dos autos originários que a razão do indeferimento da solicitação formulada no âmbito administrativo decorreu da falta de cobertura contratual para a realização

do exame PET-CT (nos termos do art. 22 do Decreto Estadual nº 34.680/2010), que não está incluído no protocolo da central de oncologia do SISMEPE . 5. Embora a Lei Federal nº 9.656/98 não abranja os sistemas de saúde mantidos pelas pessoas jurídicas de direito público para os militares, estes militares, mesmo não qualificados como consumidores (na acepção tradicional de direito privado), não podem ficar à completa mercê das decisões administrativas que deliberem incluir ou excluir determinados procedimentos do âmbito de cobertura, o que em última análise resultaria em cláusula potestativa francamente incompatível com o caráter oneroso do sistema. 6 . Deveras, a circunstância de o SISMEPE ser estruturado em bases estatutárias não significa que não se apliquem aos servidores (a eles compulsoriamente vinculados), e aos seus dependentes, por identidade de razão jurídica, pelos menos algumas das regras protetivas comumente regentes das relações de consumo que envolvem planos de saúde privados, em especial quanto ao efetivo conhecimento das condições e limites do sistema no momento da adesão e à prévia comunicação, a tempo e modo, das eventuais alterações das regras originárias. 7. Dentro dessa perspectiva, a imprescindibilidade da realização do exame solicitado (PET-CT) resta evidenciada pela apreciação do 'laudo médico' e da 'solicitação médica' acostados aos autos, subscritos pelo Dr. Bruno A . Miranda (CRM 16.245), do NEOH – Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia. 8. E, nos termos do Ofício nº 001/2018 acostado aos autos originários, emitido pela Diretoria de Saúde da PMPE, tem-se que a reguladora de exames externos da PMPE (Baker Tilly) buscou um local no qual se pudesse realizar o exame de "PET-CT" por meio de nota de empenho, vindo o mesmo a ser autorizado, liberado, e realizado pelo Real Hospital Português de Pernambuco . 9. Assim, no plano da verossimilhança das alegações, tem-se que a realização do exame solicitado não se afigura excepcional ou extraordinária, não se justificando, sob o prisma do princípio da razoabilidade, a negativa de seu custeio (precedentes deste TJPE). 10. Destarte, é de ser mantida a multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau (R$ 1 .000,00/dia de descumprimento), posto que à parte agravada não interessa o recebimento da multa, mas sim o cumprimento efetivo, a tempo e modo, da obrigação de fazer, consistente no custeio do exame solicitado, sendo indispensável, pois, que o preceito cominatório seja suficiente para desestimular um eventual inadimplemento. 11. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0000379-29 .2018, acima referenciado, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que integra o acórdão. Recife, de de 2018 (data do julgamento). Des. Francisco Bandeira de Mello Relator

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0000379-29 .2018.8.17.9000, Relator.: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 04/05/2018, Gabinete do Des . Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Francisco Bandeira de Mello AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014818-45.2018 COMARCA: Recife AGRAVANTE: Estado de Pernambuco AGRAVADO: Luiz Antônio Guimarães Motta RELATOR: Des. Francisco Bandeira de Mello EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. CUSTEIO, PELO SISMEPE - SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RTUP - RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PRÓSTATA, COM A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL CIRÚRGICO NECESSÁRIO. BENEFICIÁRIO/PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS, CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE E HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (CID 10: N40) . COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. DEVER DO SISMEPE. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O SISMEPE - Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco foi criado pela Lei Estadual nº 13.264, de 29 de junho de 2007, a qual se encontra regulamentada pelo Decreto nº 34.680, de 12 de março de 2010. 2 . Destina-se à prestação de serviços de assistência à saúde, no âmbito do Estado de Pernambuco, exclusivamente aos seus beneficiários definidos no Capítulo III daquela Lei, através de ações de medicina preventiva e curativa, desenvolvidas mediante aplicação de programas específicos de assistência à saúde e por intermédio das organizações militares de saúde da Polícia Militar de Pernambuco - PMPE e excepcionalmente por entidades, profissionais ou hospitais credenciados ao SISMEPE, na forma desta Lei. 3. Da leitura dos artigos 2º, § 4º, e 18, da Lei Estadual nº 13.264/2007, infere-se que o SISMEPE é um sistema de adesão compulsória para os militares, ativos e inativos, cujo custeio conta com a participação dos seus beneficiários, além de contribuição fixa do Tesouro Estadual, razão pela qual sua função não se confunde com a desempenhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cujo acesso é universal e igualitário, sem qualquer limite de cobertura de tratamentos . 4. Embora a Lei Federal nº 9.656/98 não abranja os sistemas de saúde mantidos pelas pessoas jurídicas de direito público para os militares, estes militares, mesmo não qualificados como consumidores (na acepção tradicional de direito privado), não podem ficar à completa mercê das decisões administrativas que deliberem incluir ou excluir determinados procedimentos do âmbito de cobertura, o que em última análise resultaria em cláusula potestativa francamente incompatível com o caráter oneroso do sistema. 5 . Deveras, a circunstância de o SISMEPE ser estruturado em bases estatutárias não significa que não se apliquem aos servidores (a eles compulsoriamente vinculados), e aos seus dependentes, por identidade de razão jurídica, pelos menos algumas das regras protetivas comumente regentes das relações de consumo

que envolvem planos de saúde privados, em especial quanto ao efetivo conhecimento das condições e limites do sistema no momento da adesão e à prévia comunicação, a tempo e modo, das eventuais alterações das regras originárias. 6. Dentro dessa perspectiva, a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico solicitado (RTUP) resta evidenciada pela apreciação da 'prescrição médica' e das 'solicitações médicas' acostadas aos autos, subscritas pelo Dr. Rodolfo Pacheco (CRM/PE 15 .729), do Centro Médico Hospitalar da própria PMPE. 7. Assim, no plano da verossimilhança das alegações, tem-se que a realização do procedimento cirúrgico solicitado não se afigura excepcional ou extraordinária, não se justificando, sob o prisma do princípio da razoabilidade, a negativa de seu custeio (precedentes deste TJPE). 8 . De outra parte, é de ser reduzida a multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau (em R$ 2.000,00/dia de descumprimento), embora não interesse à parte agravada o recebimento da multa, mas sim o cumprimento efetivo, a tempo e modo, da obrigação de fazer (consistente no custeio do procedimento cirúrgico solicitado). 9. Isso porque o preceito cominatório é de ser fixado em patamar suficiente para desestimular um eventual inadimplemento (e não em patamar exorbitante), razão pela qual reduziu-se as astreintes para o valor de R$ 1 .000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 10. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para reduzir a R$ 1.000,00 (mil reais) o valor do preceito cominatório, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0014818-45.2018, acima referenciado, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Relator, que integra o acórdão. Recife, de de 2019 (data do julgamento). Des . Francisco Bandeira de Mello Relator

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0014818-45.2018.8.17 .9000, Relator.: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 25/03/2019, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães , S/N, Tribunal de Justiça (3º andar), RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:(81) 31820198 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0003401-27.2020.8 .17.9000 AGRAVANTE: ANDERSON CLEITON ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SISMEPE, PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISMEPE . OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM BASE NO MÉTODO ABA A PORTADOR DE AUTISMO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR AO SISMEPE O CUSTEIO DO TRATAMENTO POSTULADO. 1 . Discute-se, no presente caso, acerca da pretensão de obrigar o SISMEPE a custear tratamento multidisciplinar a portador de AUTISMO com base nos métodos ABA (Applied Behaviour Analysis). 2. Esta Corte de Justiça tem reconhecido a obrigação de cobertura, pelos planos de saúde, do tratamento ora em discussão, tratando como ilícitas as cláusulas contratuais que excluam tais métodos. Há entendimento, inclusive, que reconhece a existência de dano moral indenizável em face da negativa de cobertura em tais casos . Neste sentido: APEL 406904-5 (0058281-44.2013.8.17 .0001), 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eurico de Barros Correia Filho, DJe: 08/11/2016. 3 . Conquanto se reconheça que o SISMEPE, no intuito de manter a higidez de suas finanças, detém liberdade para afastar do âmbito de sua cobertura algumas espécies de despesas, faz-se mister verificar que, na presente hipótese, em confronto com os interesses econômicos da entidade estão interesses superiores da agravada, quais sejam, seu direito à saúde e à vida. 4. Logo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de garantir a todos os cidadãos, mormente os mais carentes, o direito constitucionalmente assegurado à manutenção da saúde (art. 196), consequência indissociável do direito à vida, justifica a imposição da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, conforme orientação jurisprudencial uníssona deste Sodalício . 5. Assim, dúvida não há de que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. 6. Com efeito, na hipótese, verificou-se que a pretensão do beneficiário da medida encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, a condição de hipossuficiência, a existência da enfermidade, a necessidade do tratamento requestado . 7. É indubitável que a obrigação do SISMEPE exsurge por imposição do vínculo contratual estabelecido entre ambas as partes, sendo certo que a segurada honrou com sua prestação, devendo ser ressaltado, inclusive, que já se encontra superada a questão da aplicação da legislação consumerista sobre a espécie, nos termos da jurisprudência do STJ. 8. Agravo de instrumento provido, reformando a decisão agravada para determinar ao SISMEPE o custeio de tratamento pelo método ABA, na Clínica SOMAR, ao tempo em que declarou-se a perda do objeto do Agravo Interno de id 10691386 .

(TJ-PE - AI: 00034012720208179000, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

1ª Câmara REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO nº 0010833-29.2021.8.17 .2480 Juízo de Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru Apelante: ESTADO DE PERNAMBUCO Apelado: ANTONIO RODRIGUES FILHO Relator.: Des. Honório Gomes do Rego Filho ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO SISMEPE . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJPE. FACULDADE A SER EXERCIDA PELO MILITAR ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. Os serviços de saúde constituem atividade de interesse público também passível de exploração sob regime de direito privado. No presente caso, a cobertura contratual prestada pelo SISMEPE perfaz-se mediante desconto de contribuições dos servidores estaduais militares, o que demonstra seu caráter oneroso, voluntário e facultativo, devendo-se afastar, por ora, a aplicação do regime de direito público típico das prestações de caráter tributário . 2. A contribuição vertida ao custeio do SISMEPE não poderia mesmo ostentar qualquer caráter compulsório, à medida que falece aos Estados competência constitucional para instituição de contribuições especiais para seguridade social, única hipótese que poderia legitimar os descontos para financiamento dos serviços de assistência à saúde prestados pelo Estado. 3. A instituição de contribuições compulsórias para financiamento dos serviços de saúde do Estado extravasa sua competência constitucional . Isso significa que, no âmbito dos Estados, a prestação dos serviços de saúde só poderia ser financiada com recursos dos impostos (de destinação livre e não vinculada, segundo art. 167, IV, CF) ou através da instituição de contribuições VOLUNTÁRIAS dos servidores beneficiados, tal como ocorre com o SISMEPE. 4. Apelo não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cívelnº 0010833-29.2021.8.17 .2480, em que figuram como Apelantes: ESTADO DE PERNAMBUCO e Apelado: ANTONIO RODRIGUES FILHO, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, na data da assinatura eletrônica. Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H13

(TJ-PE - AC: 00108332920218172480, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2022, Gabinete do Des . Honório Gomes do Rego Filho)

1ª Câmara REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO nº 0000746-95.2022.8.17 .2280 APELANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO e FUNAPE e OUTRO APELADO: JOSE EDUARDO BEZERRA DA SILVA e OUTROS RELATOR: Des. Honório Gomes do Rego Filho APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO SISMEPE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJPE. FACULDADE A SER EXERCIDA PELO MILITAR ESTADUAL . RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os serviços de saúde constituem atividade de interesse público também passível de exploração sob regime de direito privado . No presente caso, a cobertura contratual prestada pelo SISMEPE perfaz-se mediante desconto de contribuições dos servidores estaduais militares, o que demonstra seu caráter oneroso, voluntário e facultativo, devendo-se afastar, por ora, a aplicação do regime de direito público típico das prestações de caráter tributário. 2. A contribuição vertida ao custeio do SISMEPE não poderia mesmo ostentar qualquer caráter compulsório, à medida que falece aos Estados competência constitucional para instituição de contribuições especiais para seguridade social, única hipótese que poderia legitimar os descontos para financiamento dos serviços de assistência à saúde prestados pelo Estado. 3 . A instituição de contribuições compulsórias para financiamento dos serviços de saúde do Estado extravasa sua competência constitucional. Isso significa que, no âmbito dos Estados, a prestação dos serviços de saúde só poderia ser financiada com recursos dos impostos (de destinação livre e não vinculada, segundo art. 167, IV, CF) ou através da instituição de contribuições VOLUNTÁRIAS dos servidores beneficiados, tal como ocorre com o SISMEPE. 4 . Não há como se admitir que um serviço indevidamente imposto, mediante descontos compulsórios igualmente impositivos e indevidos, gere uma consequência jurídica similar às situações em que o indivíduo voluntariamente adere um plano de saúde e dele usufrui. Não se faz razoável que alguém sofra descontos remuneratórios compulsórios para alimentar um serviço cuja utilização não era pretendida e, após a constatação da ilegalidade dessas supressões remuneratórias, não faça jus à respectiva restituição. Sendo os descontos ilegais, deve haver a desconstituição da relação jurídica (repise-se, compulsoriamente formada) e, por conseguinte, a restituição dos valores indevidamente retirados da esfera patrimonial de seu titular. É regra basilar de nosso ordenamento jurídico a necessidade de retorno ao "estado natural das coisas", mais tecnicamente denominada de "status quo ante" - normativa esta que não pode ser ignorada . 5. Eventual utilização dos serviços de saúde decorrentes do SISMEPE altera o cenário acima exposto, na medida em que a admissão da repetição do indébito levaria ao enriquecimento ilícito do servidor - que estaria agindo de forma contraditória ao seu comportamento anterior, o que se faz vedado, conforme regra do "venire contra factum proprium". À vista disso, nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia aos demandados demonstrarem a efetivação utilização, pelo autor, dos serviços disponibilizados através do SISMEPE, de modo que, não o tendo feito, o acolhimento da pretensão restituitória é medida que se impõe . 6. Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cívelnº 0000746-95.2022 .8.17.2280, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional

de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, na data da assinatura eletrônica . Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H10

(TJ-PE - AC: 00007469520228172280, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2023, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0055962-39.2021.8 .17.2001 RECORRENTES: A. D. N . D. S. e SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SISMEPE RECORRIDOS: A. D . N. D. S. e SISMEPE RELATOR: DES . ANTENOR CARDOSO SOARES JÚNIOR EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA AUTISTA . OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . SÚMULA 138 DO TJPE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por A. D. N . D. S. e pelo Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco (SISMEPE) contra sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico. A parte autora apelante busca também o reconhecimento de danos morais pela negativa de tratamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o SISMEPE deve custear o tratamento multidisciplinar para TEA, conforme prescrição médica; (ii) estabelecer se a negativa do SISMEPE ao fornecimento de tratamento gera o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O SISMEPE, sendo entidade de autogestão, não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, porém deve respeitar as normas da Lei 9 .656/1998, que impõe a cobertura de tratamentos necessários à saúde. A negativa do SISMEPE em fornecer o tratamento prescrito (métodos ABA, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, entre outros) é indevida, pois tais abordagens possuem caráter terapêutico e visam à melhoria das condições de saúde do paciente autista. O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito, incluindo a possibilidade de uso de rede privada quando a rede credenciada do plano não atender à demanda. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois a negativa do SISMEPE, apesar de questionável, não configurou ato ilícito capaz de causar dano moral, nos termos da Súmula 138 do TJPE . IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Sentença mantida. Decisão unânime . Tese de julgamento: 1. O plano de autogestão deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para portador de TEA, quando necessário para garantir a saúde e o desenvolvimento do paciente. 2. A negativa administrativa de fornecimento de tratamento por razões procedimentais não enseja indenização por danos morais, desde que não haja dolo . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações nº 0055962-39.2021.8.17 .2001, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, unanimemente, em negar provimento aos dois recursos de apelação, tudo em conformidade com a ementa, o relatório e o voto do Relator, que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00559623920218172001, Relator.: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2024, Gabinete do Des . Antenor Cardoso Soares Júnior)

DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais decorrentes da negativa do ou demora na contraprestação médica que deveria ter sido disponibilizada a parte beneficiária, ressaltando-se que a demora ou a negativa surtem o mesmo efeito para a parte autora que necessitou do tratamento de urgência o qual não fora disponibilizado pelo réu, caracterizando a omissão do réu e a condenação do mesmo em danos morais.

A negativa se encontra comprovada nos autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência do nosso tribunal:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ªTPCRC - F:() 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU - 2ª TURMA Apelação n.0003467-12.2019 .8.17.2640 Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública da comarca De Garanhuns Apelante:Estado de Pernambuco Apelado:Espólio de Salatiel Oliveira da Silva Relator.: Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS MILITARES. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL . REGRAS DE PROTEÇÃO AO ADERENTE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO . DANO MORAL REFLEXO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM . 1. A obrigação patrimonial estabelecida em sentença de obrigação de fazer e indenização por

dano moral é distinta do dever de fornecer tratamento ou insumo médico. Somente essa última obrigação é personalíssima e intransmissível, não a obrigação de pagar. Preliminares de ilegitimidade do espólio para pleitear indenização e de nulidade da sentença recorrida rejeitadas . 2. A Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, aplica-se aos sistemas de assistência à saúde mantidos por pessoas jurídicas de direito público em favor dos seus servidores . Precedentes do STJ. 3. A súmula n. 608 do STJ afasta a incidência do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão sem fins lucrativos e com grupo restrito de filiados . 4. No caso em análise, a parte autora, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, comprova, através de documentos juntados com a petição inicial, a qualidade de filiada ao SISMEPE e a necessidade de se submeter a tratamento através de hospitalização em domicílio, pleito indevidamente denegado pelo órgão de assistência à saúde dos servidores militares do Estado de Pernambuco. 5. O dano moral advém de lesão a direitos da personalidade, e a indenização que daí se origina destina-se a reparar o prejuízo imaterial e prescinde, em muitos casos, de comprovação de sentimentos desagradáveis pelo ofendido . 6. O dano moral reflexo ou por ricochete se constitui em direito de compensação das pessoas intimamente relacionadas com a vítima imediata do ato ilícito. Essas pessoas, geralmente na qualidade de herdeiros, sofrem dano em seus direitos fundamentais em decorrência do dano suportado pela vítima direta. 7 . No caso concreto, o dano moral está suficientemente demonstrado pela negativa do réu em fornecer o procedimento a que faz jus, nos termos da legislação e do entendimento jurisprudencial aplicáveis à espécie. 8. O valor fixado na sentença recorrida, a título de indenização pelo dano moral sofrido, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é suficiente para indenizar a parte autora e atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade . 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru-PE, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado . Caruaru, data da certificação digital. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador Relator P14

(TJ-PE - AC: 00034671220198172640, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2023, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ªTPCRC)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães Apelação Cível nº 0039312-14.2021.8 .17.2001 Apelante: Angélica Rodrigues Ferreira Apelado: Sistema de Saúde dos Militares Estaduais de Pernambuco – SISMEPE Relator.: Des. José Ivo de Paula Guimarães EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL . PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SISMEPE . SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PESSOA IDOSA . NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO SISMEPE O FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO NOS TERMOS CONSTANTES EM RELATÓRIO MÉDICO. CONSTITUI ÔNUS DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PRESTADORES VINCULADOS À REDE CREDENCIADA COM APTIDÃO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO, ADMITE-SE O TRATAMENTO POR PRESTADOR NÃO CONVENIADO . DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PACIENTE QUE AGUARDOU POR ANOS A AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE . 1. A pretensão da apelada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso no art. 196, da Constituição Federal e na Súmula nº 18 deste Egrégio Sodalício. 2 . Ademais, conquanto se reconheça que o Sistema de Assistência à Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco – SISMEPE, no intuito de manter a higidez de suas finanças, detém liberdade para afastar do âmbito de sua cobertura algumas espécies de despesas, faz-se mister verificar que, na presente hipótese, em confronto com os interesses econômicos da entidade, estão interesses superiores do apelado, quais sejam, seu direito à saúde e à dignidade. 3. Com efeito, na hipótese, verifico que a pretensão do beneficiário da medida encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, restando claro, através da declaração médica, que a paciente é pessoa idosa (atualmente com 74 anos) e portadora de Estenose de Canal Lombar (CID 10 M48.0), tendo sido aposentada em razão da doença . Ao realizar consulta com médico vinculado ao SISMEPE, Dr. Rodrigo Freitas, no ano de 2018, foi constatada a necessidade de intervenção cirúrgica (ID 36801749), em virtude do agravamento da doença. 4. Quanto à aplicação das regras da relação de consumo, no julgamento do REsp . nº 1.285.483, que espelhou o entendimento contemplado naquela Corte de Justiça, o STJ decidiu pela inaplicabilidade das regras contidas no CDC em relação aos planos de saúde de autogestão, que é o caso do Sassepe. 5 . Dessarte, restou anulada a Súmula nº 469, do STJ, que tinha o seguinte teor: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.", ao tempo em que fora editada a Súmula nº 608, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". A publicação do dispositivo ocorreu em 17/04/2018. Não obstante a alteração sumular, os planos de saúde, ainda que de autogestão, continuam com a obrigação de prestar os serviços de saúde da forma mais eficiente possível, resguardando a vida como direito maior a ser defendido, respeitando o compromisso contratual . 6. No caso em apreço, restou devidamente comprovada a necessidade da parte autora de se submeter ao procedimento indicado, sendo de conhecimento público e

notório a urgência que se recomenda para o início do tratamento deste tipo de patologia, sob pena de risco de irreparabilidade do seu quadro clínico, que se encontra ainda em desenvolvimento. 7. Quanto ao montante fixado na sentença pelo juízo a quo, a título de danos morais no valor de R$ 1 .500,00 (um mil e quinhentos reais), tenho que deve ser avaliada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Da leitura dos autos, mesmo com todos os percursos ocorridos para o diagnóstico (a identificação da doença e o seu estágio por meio do reconhecimento dos sintomas e da análise de exames) e prognóstico (manifestação do médico quanto às possíveis consequências que a doença pode causar ao paciente e qual o devido tratamento da doença diagnosticada), por mais de 03 anos, que as vezes acontecem por atos demasiadamente burocráticos, e com o surgimento da pandemia, veio ainda mais dificultar as ações que deveriam ser tomadas pelo Ente Público, que, só assim então, teve seu desfecho através da liminar. Em razão desses fatos, vejo como razoável e satisfatória a majoração da condenação reparatória por dano moral, fixando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 8. Apelo provido parcialmente.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00393121420218172001, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/09/2024, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Já em relação ao valor da indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, considerando a extensão do dano e as finalidades compensatória e inibitória da medida.

DIANTE DO EX´POSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA:**

A) **DETERMINAR AO CENTRO HOSPITALAR DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO/SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SISMEPE** FORNEÇAM a autora **MARIA ZÉLIA BISPO DA SILVA** o medicamento **TEMODAL® (TEMOZOLAMIDA) 300 MG,** sendo ministradas cinco doses seguidas a cada 28 (vinte e oito) dias, no total de doze ciclos (um ano), conforme laudo médico constante nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de valores para satisfação da medida, devendo a parte autora juntar aos autos laudo médico a cada seis meses para comprovar a necessidade de manutenção do tratamento, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida.

B) **CONDENAR** o réu ao pagamento de indenização por danos morais a **PARTE AUTORA** no importe de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

O valor deverá ser atualizado pela SELIC, os juros de mora a partir da citação (15/01/2025) e a correção monetária a partir da sentença.

Sem condenação em custas processuais.

Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Eventual cumprimento de sentença <u>referente a tutela concedida</u> deve ser feito em autos próprios.

Assim, intime-se a parte autora para requerer o cumprimento de sentença nos termos da antecipação tutela concedida nos autos e confirmada na sentença em caso de descumprimento.

Transitada em julgado, intime-se aparte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o cumprimento de sentença.

Apresentado Recurso de apelação por qualquer uma das partes, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, a fazenda pública no prazo de 30(trinta) dias e o jurisdicionado no prazo de15 (quinze) dias.

Juntada as contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Garanhuns, 13 de agosto de 2025

Glacidelson Antônio da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: GLACIDELSON ANTONIO DA SILVA
13/08/2025 18:31:04
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 212801766

25081318310460400000207178950

IMPRIMIR GERAR PDF